

# BD a ciąża i macierzyństwo

Ciąża u kobiety z BD wymaga planowania. Część leków stwarza ryzyko dla płodu, część można utrzymać. Bez stabilizatora ryzyko nawrotu w połogu jest bardzo wysokie.

**CZAS:** 25 min — psychoedukacja **CHARAKTER:** planowanie reprodukcyjne

**ŹRÓDŁO:** Yatham CANMAT (2018); NICE (2014)

## JAK UŻYWAĆ

Planuj ciążę z **wyprzedzeniem 3-6 miesięcy**. Skonsultuj z psychiatrą: który lek jest najbezpieczniejszy w ciąży? Czy można zmienić walproinian/karbamazepinę (przeciwwskazane)? Stabilizacja na zmienionym leku  $\geq 3$  miesiące przed staraniem się. Kwas foliowy 4 mg/dzień. Plan na połóg: lek + sen 6+ h + wsparcie partnera + wizyta u psychiatry w 1. tygodniu po porodzie.

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Viguera i wsp. (2007): **50-70%** kobiet z BD doświadcza nawrotu w ciąży lub po porodzie, jeśli odstawi stabilizator. Połóg (pierwsze 6 tyg.) — ryzyko 4-6× wyższe. Yatham CANMAT (2018): „kluczowy moment to **planowanie**, nie improwizacja. Kobieta z BD powinna mieć czas na **ustabilizowanie leku** zgodnego z ciążą”. Ciąża nie „leczy” BD — wbrew mitowi.

## 01 Lek w ciąży — krótki przegląd

Decyduje zawsze z psychiatrą. Lista orientacyjna na rozmowę.

### WYSOKIE RYZYKO

**Walproinian (Depakine):** wady cewy nerwowej, ↓ IQ. **Przeciwwskazany.** **Karbamazepina:** wady cewy. **Unikać.**

### NISKIE RYZYKO

**Lit:** niskie ryzyko Ebsteina (1:1000). *Można utrzymać z monitoringiem.* **Lamotrygina:** względnie bezpieczna.

### WZGLĘDNIIE BEZPIECZNE

**Kwetiapina, olanzapina:** dobry profil. *Można stosować.* **Aripiprazol:** ograniczone dane.

### KARMIENIE PIERSIĄ

Lit przenika do mleka — zwykle przerwa. Kwetiapina, lamotrygina — względnie bezpieczne. Indywidualnie z psychiatrą.

## 02 Plan ciąży — 6 kroków

1. Rozmowa z psychiatrą z **wyprzedzeniem** (3-6 mies. przed planowaną ciążą).
2. Ocena: który lek najbezpieczniejszy? Czy można zmienić na bezpieczniejszy?
3. Stabilizacja na zmienionym leku —  $\geq 3$  miesiące bez nawrotów przed staraniem się.
4. Kwas foliowy 4 mg/dzień (lek przeciwpadaczkowy) lub 0,4 mg (inne).
5. Współpraca: psychiatra + położnik + neonatolog. Zespół poinformowany o BD.
6. Plan na połóg: lek po porodzie, sen 6+ h, wsparcie, wizyta u psychiatry w 1. tygodniu.

### 03 ✕ Połóg — okres zwiększonego ryzyka

Pierwsze 6 tygodni po porodzie to czas najwyższego ryzyka nawrotu BD.

#### Plan zabezpieczenia:

- Lek profilaktyczny rozpoczęty *natychmiast* po porodzie (lub utrzymany).
- Sen *minimum 6 godzin* ciągłej fazy nocnej (partner / rodzina przejmują karmienia).
- Wizyta u psychiatry w pierwszym tygodniu po porodzie.
- Plan kryzysowy: kiedy zgłaszamy się natychmiast (objawy manii, depresji, psychozy poporodowej).
- Wsparcie partnera / rodziny przygotowane *przed* porodem.

**Psychoza poporodowa:** rzadka, ale poważna (1:1000 ogólnie, 20–30× częściej u kobiet z BD).  
Halucynacje, urojenia, dezorientacja w 1.–2. tyg. *Stan zagrożenia życia* — pilna hospitalizacja.

### 04 ✎ Mój plan

AKTUALNY LEK

#### CZY BEZPIECZNY W CIĄŻY?

*wymaga konsultacji z psychiatrą*

#### KONSULTACJA Z PSYCHIATRĄ (DATA)

#### KONSULTACJA Z POŁOŻNIKIEM (DATA)

#### PLAN ZMIANY LEKU (JEŚLI POTRZEBNA)

#### STABILNOŚĆ PRZEZ 3 MIESIĄCE — OD KIEDY

#### WSPARCIE W POŁOGU

*partner / rodzina / pomoc nocna*

#### TELEFON KRYZYSOWY (PSYCHIATRA)

**Klucz:** Yatham CANMAT (2018): „kobieta z BD może bezpiecznie zostać matką — ale wymaga to **planowania**, wsparcia i utrzymania leczenia. Improwizacja prowadzi do tragedii”. Rozmawiaj z psychiatrą wcześniej.